



**Universidad
Norbert Wiener**

Powered by **Arizona State University**

UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER

Facultad de Ciencias de la Salud

Escuela Académico Profesional De Obstetricia

Proyecto de tesis

“Tipificación del virus de papiloma humano y características en mujeres del Centro de Salud Mirones Bajo. 2024-2025”

Para optar el grado académico de

Licenciada en Obstetricia

Presentado por:

Autora: Mendoza Sulca, Ariana Solange

Código ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6176-1768>

Asesora: Mg. Hidalgo Vara, Luz Susana

Código ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9134-1454>

Línea de investigación:

Salud y bienestar

Lima, Perú

2025

Índice

1. EL PROBLEMA	5
1.1. Planteamiento del problema	5
1.2. Formulación del problema	7
1.2.1. Problema general	7
1.2.2. Problema específico	8
1.3. Objetivos de la investigación	8
1.3.1. Objetivo general	8
1.3.2. Objetivos específicos	8
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	8
1.4.1. Teórica.....	9
1.4.2. Metodológica.....	9
1.4.3. Práctica.....	10
1.5. Delimitaciones de la investigación	10
1.5.1. Delimitación geográfica	10
1.5.2. Delimitación temporal	10
1.5.3. Delimitación de recursos.....	11
2. MARCO TEORICO.....	12
2.1. Antecedente de la investigación	12
2.1.1. Antecedentes Internacionales	12
2.1.2. Antecedentes Nacionales	14

2.2.	Bases teóricas	16
2.2.1.	Virus Del Papiloma Humano.....	16
2.2.2.	Clasificación del VPH.....	17
2.2.5.	Diagnóstico del VPH	18
2.2.6.	Características sociodemográficas.....	19
2.3.	Formulación de hipótesis	21
2.3.1.	Hipótesis general	21
2.3.2.	Hipótesis específica	21
3.	METODOLOGÍA.....	22
3.1.	Método	22
3.2.	Enfoque	22
3.3.	Tipo de investigación	22
3.4.	Diseño de investigación	23
3.5.	Población, muestra y muestreo.....	23
3.5.1.	Población.....	23
3.5.2.	Muestra	24
3.5.3.	Muestreo.....	24
3.6.	Variables y operacionalización.....	25
3.7.	Procedimientos y técnicas	Error! Bookmark not defined.
3.7.1.	Técnica	29
3.7.2.	Instrumento	29
3.7.3.	Validación.....	30

3.7.4. Confiabilidad.....	30
3.8. Análisis de Datos	30
3.9. Aspectos éticos	31
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	32
4.1. Cronograma.....	32
4.2. Presupuesto	33
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	34
Anexo 1: Matriz de Consistencia.....	38
Anexo 2: Instrumento.....	40
Anexo 3: Validez del instrumento.....	42
Anexo 4: Informe del asesor de Turnitin.....	48

1. EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

El Virus de Papiloma Humano (VPH) es actualmente una de las principales infecciones de transmisión sexual más contagiosa y silenciosa que afecta tanto a hombres como mujeres, hasta el momento se sabe de la existencia de más 100 tipos de dicho virus y por las propiedades oncogénicas que poseen algunos tipos de VPH denominados de alto riesgo como el tipo 16 y 18 pueden atacar el cuello uterino y formar neoplasias intraepiteliales que pueden persistir y con el paso de tiempo convertirse en cáncer de cuello uterino. (1)

A nivel mundial el VPH es una problemática para la salud pública, afecta a toda una comunidad mundial, pero en su mayoría a la población femenina, sobre todo a mujeres provenientes de países con bajos recursos económicos o en vías de desarrollo. Diversos estudios demostraron la rápida propagación de este virus, se estima que una mujer sexualmente activa y con una sola pareja sexual tiene hasta un 49% de contagiarse de VPH, dicha cifra aumenta hasta un 99 % de probabilidades de contagio si el número de parejas sexuales aumenta hasta cinco veces más. (2)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que durante el 2024 se reportó aproximadamente más de 300 millones de mujeres de todo el mundo con VPH, donde la prevalencia con mayor cantidad de casos se encuentra en el continente africano con un porcentaje de 24%, en segundo lugar, está América Latina y Caribe con un 16% y en menor porcentaje se encuentran los continentes de Europa Oriental con un 14% igualando al continente asiático con un 14% (3). Respecto al cáncer de cuello uterino a nivel mundial GLOBOCAN 2022 menciona que la incidencia a nivel mundial fue de

aproximadamente más de 660 000 casos de cáncer de cérvix, con una mortalidad estimada de más de 340 000 mujeres en el año 2022 (4,5).

En América latina, específicamente en Brasil, Su Ministerio de Salud mencionó que el 54,4% de la población femenina estas contagiada del VPH genital, siendo el virus más común en su país que ocasiona cáncer de cuello uterino y anal con un 90% (6). Por otro lado, en Bolivia por medio del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud revela que se realizó 44 320 tamizajes de VPH, donde el 20,5% salió positiva a la infección igualmente mencionan que entre los años 2016 hasta el 2023 se detectaron 13 415 casos de cáncer de cuello uterino (7).

En un estudio elaborado por Araujo y colaboradores mencionan que entre el año 2018 al 2021 de 68 714 mujeres de diversas regiones del país sometidas a un tamizaje de VPH la región con mayor porcentaje fue Piura con una prevalencia de 16,85% y en menor porcentaje se encuentran las mujeres de Arequipa donde se mostró que el 12.58% tuvo VPH positivo (8). Respecto al cáncer de cuello uterino, el Ministerio de Salud (MINSA) reportó 4 270 casos de mujeres con cáncer en el año 2020, de las cuales 2 288 mujeres fallecieron, es decir, aproximadamente la mitad de las mujeres con diagnóstico de cáncer de cuello uterino fallecen (9). El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mencionó que el primer trimestre del 2024 se detectaron 1311 casos de cáncer de cuello uterino gracias a la prueba molecular del VPH (10).

Se estima que para el año 2030 la incidencia de muerte de mujeres con esta enfermedad podría aumentar hasta en un 45%, siendo una cifra alarmante pero no extraña si tenemos en cuenta que en América Latina y el Caribe la probabilidad de que

una mujer fallezca por cáncer de cuello uterino es tres veces más a una mujer de Norteamérica y probablemente se deba a la diferencia en acceso y calidad de servicio de salud, asumiendo que en el Perú, el cáncer de cuello uterino por el VPH es la segunda causa de mortalidad en las mujeres (9). Por ende, por medio del MINSA vieron la importancia de contar como estrategia la implementación de pruebas moleculares con el fin de un diagnóstico más específico y sensible, aprobando en el 2019 la Resolución Ministerial N° 085-MINSA/2019/DGIESP "Directiva Sanitaria para la prevención del cáncer de cuello uterino mediante la detección temprana y tratamiento de lesiones pre malignas incluyendo carcinoma in situ”.

En Huaral por medio de la DIRISA se creó el primer laboratorio en usar pruebas moleculares y distribuir las a todos los Centros de Salud, cuyo propósito fue detectar tempranamente el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino ayudando a facilitar un tratamiento precoz y evitar complicaciones. Solo en este año MINSA reportó que se logró tamizar a más de 141 00 mujeres, siendo Lima Norte la DIRIS con más tamizajes realizadas, con 13 817. Por otra parte, el Centro de Salud Mirones Bajo viene realizando tamizajes de VPH desde el año 2021 a todas las pacientes mayores de 30 a 49 años con el fin de detectar tempranamente este virus en mujeres asintomáticas y evitar el progreso de lesiones cancerígenas. (11,12).

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿Cuál es la tipificación del virus de papiloma humano y características de las mujeres del Centro de Salud Mirones Bajo, 2024-2025?

1.2.2. Problema específico

- ¿Cuáles son las características sociodemográficas de mujeres con infección al virus de papiloma humano?
- ¿Cuáles son las características gineco- obstétricas de mujeres con infección al virus de papiloma humano?
- ¿Qué tipo de cepa prevalece en las mujeres con infección del virus de papiloma humano?

1.3.Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

Determinar la tipificación del virus de papiloma humano y características en mujeres del Centro de Salud Mirones Bajo. 2024-2025

1.3.2. Objetivos específicos

- Conocer las características sociodemográficas de mujeres con infección al virus de papiloma humano.
- Establecer las características gineco- obstétricas de mujeres con infección al virus de papiloma humano
- Identificar que cepa prevalece en las mujeres con infección de virus de papiloma humano.

1.4. Justificación de la investigación

La presente investigación encuentra su fundamento en la necesidad de determinar la prevalencia del virus del papiloma humano y caracterizar a la población. Como se relató la importancia de detectar tempranamente a infección es para atenuar o

retrasar la aparición de cáncer de cuello uterino, que es a nivel mundial una de las principales causas de muerte en la mujer.

1.4.1. Teórica

Como ya se mencionó en VPH es uno de los principales problemas de salud pública y la importancia de caracterizar a la población se centra en determinar que grupos de individuos son más propensos a la infección , actualmente existen diversos trabajo de investigación sean nacionales o internacionales donde la prevalencia y características varían según el área geográfica o estatus socioeconómico, por lo cual justifica la necesidad de estudios locales que aporten datos actuales y en nuestro contexto social. Dicho trabajo será elaborado por primera vez en el Centro de Salud de Mirones Bajo y dará conocimiento local y fidedigno de la problemática actualmente, donde no solo está dirigido a la comunidad científica, sino también al personal de salud y lectores en general.

1.4.2. Metodológica

Este estudio va a utilizar un método que se ajusta a la necesidad propia de la investigación. Se utilizará un enfoque cuantitativo ya que buscamos solo medir las características de las mujeres con VPH positivo y cuantificarlas en porcentajes, mas no se estudiará caso por caso como seria en un enfoque cualitativo, será descriptiva ya que solo describiremos características, será de tipo básica porque solo vamos a producir nuevos conocimientos sin otra intención como un estudio aplicado. Por otro lado, esta metodología servirá como referente para otras personas que deseen elaborar una investigación parecida a este tema, puedan utilizar esta metodología como apoyo.

1.4.3. Práctica

Mi investigación al obtener datos reales y actuales sobre las características de las mujeres con infección del VPH permitirá generar evidencia local sobre el perfil epidemiológico de las mujeres, focalizar a la población con estas características para utilizar estrategias de comunicación efectivas y llegar a ellas. Además, la producción de este conocimiento ayudará a implementar estrategias preventivas para el desarrollo de un cáncer de cuello uterino, utilizando la prevención primaria con la implementando de campañas promocionando la vacunación, campañas más continuas de tamizajes de VPH específicamente para este grupo de personas y tener un mejor resultado.

Por otra parte, contribuirá con las autoridades sanitarias a fin de que elaboren protocolos internos para mejorar el seguimiento en mujeres con VPH positivo y así evitar el desarrollo de un cáncer de cuello uterino, sobre todo en grupos más vulnerables utilizando la prevención secundaria, y así reducir los recursos del Estado Peruano. Además, ayudará al personal de salud a reconocer y ayudar a sus pacientes con características similares y poder orientar eficazmente, aconsejándolas sobre la importancia de la prevención y detección temprana de la infección,

1.5. Delimitaciones de la investigación

1.5.1. Delimitación geográfica

La presente investigación será llevada a cabo en el Centro de Salud Mirones Bajo, ubicado en el distrito de Cercado de Lima. Este lugar fue seleccionado por contar con tamizaje de VPH y su variedad geográfica.

1.5.2. Delimitación temporal

Mi investigación se centra en describir las características de las mujeres con un diagnóstico de PVH positivo durante el periodo comprendido entre enero de 2024 al

2025. Esta investigación se enfoca únicamente en recolectar datos dentro de este intervalo de tiempo con el fin de reflejar datos reales y actuales de esta problemática.

1.5.3. Delimitación de recursos

Mi investigación se desarrollará teniendo en cuenta los recursos que se encuentran a disposición, tanto humanos como materiales. Se utilizarán fuentes secundarias como son las historias clínicas y registros estadísticos. Además, se contará con herramientas básicas tales como computadoras, internet, software para análisis de datos y recursos bibliográficos. Igualmente se ajustará a los recursos disponibles para evitar comprometer la calidad y validez de dicha investigación.

2. MARCO TEORICO

2.1. Antecedente de la investigación

2.1.1. Antecedentes Internacionales

Laica N. et. Al, (2021) en su trabajo de investigación tuvo como propósito “Determinar la prevalencia de las infecciones genitales por VPH, identificar factores clínico-epidemiológicos asociados a dicha prevalencia y obtener la frecuencia de los tipos virales, en mujeres universitarias sintomáticas y asintomáticas en Ecuador, año 2020”. Dicha investigación fue de tipo descriptiva, transversal y experimental, la población fue hecha por 135 estudiantes entre 18-28 años. El instrumento que se utilizó fue una encuesta sobre los factores clínicos, y para la detección del VPH fue por reacción en cadena de la polimerasa (PCR). El resultado fue: una prevalencia de VPH de 15,56%, la edad la mayor prevalencia con mujeres de VPH fueron las mujeres de 24-28 años (57,14%), de las mujeres con VPH positivo el 66,67% iniciaron su vida sexual entre los 13 a 18 años, de las mujeres con VPH positivo, el 61,90% tuvieron entre 2 a 5 parejas y con respecto al consumo de tabaco el 90,48% de las mujeres con PVH positivo, no fumaba (13).

Morales Figueroa, et. Al. (2022) en su investigación tuvo como finalidad “determinar factores asociados a la infección de Virus del Papiloma Humano en mujeres del Noroeste del México”. La investigación fue de tipo observacional de casos y controles, para el estudio se aplicó un muestreo no probabilístico y por conveniencia donde se recolectó 33 mujeres con VPH y 66 mujeres para los controles cumpliendo criterios de inclusión. Los resultados de dicha investigación fueron: Respecto a la edad de la menarquia no se encontró significancia estadística con un (OR= 1.84 p=0.156), igualmente no se encontró relación alguna entre el inicio de la primera relación sexual $\geq$

18 años y el contagio con el VPH (OR=1.5 p=0.575). Por otro lado, los factores tales como mujeres que tuvieron más de una gestación, mujeres con muchas parejas sexuales, parejas sexuales anales y mujeres con otras ITS si tienen significancia estadística con mayor probabilidad a contagiarse de VPH con (OR= 6.1 p= 0.001), (OR= 2.4 p= 0.048), (OR= 5.9 p= 0.001) y (OR= 6.9 p= 0.016) respectivamente. Respecto a las mujeres fumadoras activas o pasivas al igual que las mujeres con AOC por más de seis años también tenían más probabilidades de contagiarse (14).

Jordá G, et. Al (2020) en dicha investigación tuvieron como objetivo “ Conocer la prevalencia de infecciones genitales por VPH, identificar factores clínico-epidemiológicos asociados a dicha prevalencia y determinar la frecuencia de los tipos virales”, la metodología que utilizaron fue de una investigación de tipo observacional, corte transversal de casos y controles con una muestra de 505 mujeres de las cuales se tomaron muestras endocervicales para la detección de VPH, igualmente se utiliza una encuesta para determinar factores clínicos y epidemiológicos. Los resultados arrojaron 155 casos positivas a VPH y 350 mujeres negativas. De los casos positivos de VPH, el 53,5% tenían entre 25 a 49 años, el 73,5% iniciaron su vida sexual entre los 13 a 18 años, el 54,2% tuvieron entre 2 a 5 pareja sexuales y solo el 19,4% usaban preservativo, entre la relación de ambos grupos y se encontró asociación estadística en el número de parejas sexuales, pero en los factores de métodos anticonceptivos, numero de embarazo o edad de relaciones sexuales no hubo significancia estadística (15).

Di Yang, et. Al (2022) en su investigación tuvieron como objetivo “Analizar las diversas características los factores de riesgo que influyen a la infección de virus del papiloma humano y lesiones precancerosas, proporcionando evidencias clínicas para el desarrollo de estrategias preventivas para las lesiones precancerosas y cáncer de cérvix”. La investigación fue de tipo transversal y se recolecto a 10 628 mujeres durante el 2018

hasta el 2021 para el descarte de cáncer cervical y tamizaje de VPH y se realizó criterios de inclusión y exclusión conformando 1244 casos de VPH y 8747 negativas para VPH. Los resultados sobre los factores de riesgo son, para el grado de instrucción de escuela secundario y menor se encontró significancia estadística con un (OR=1.27 p=0.001), igualmente el inicio de relaciones menores a los 19 años tuvo mayor riesgo a contagio con (OR=1.51 p=0.016), la cantidad mayor a 1 pareja sexual fue un (OR=1.31 p=0.002), el no uso del condón (OR=1.25 p=0.009) también fueron factores de riesgo con significancia estadística considerable. Por otra parte, no se encontró relación alguna con el contagio de VPH para la edad de la mujer, antecedente de cáncer, numero de aborto, consumo de tabaco, entre otras (16).

2.1.2. Antecedentes Nacionales

Rodríguez B (2024). En su trabajo de investigación tuvo como objetivo “Determinar las características y tipos del virus del papiloma humano de alto riesgo en mujeres de 30 a 65 años del Centro Médico y Oncológico Juan XXIII 2022”. La investigación fue un estudio cuantitativo, no experimental de corte trasversal y retrospectivo. Con una población de 120 pacientes entre los 30 a 65, se obtuvo una muestra de 33 mujeres con VPH positivo, de las cuales el rango de edad fue de 41.24 años, respecto al número de parejas sexuales el 33.3% tuvieron entre 3 a más parejas sexuales, 39.4% dos parejas sexuales, respecto al inicio de relaciones sexuales la edad con mayor predominio fue de 18.73 años, el nivel educativo más predominante fue el grado superior con un 68.3% y el VPH más común fue el otros VPH 16 con un 72.7% (17).

Denegri Hinostroza. (2024). En su investigación tuvo como objetivo “Determinar la prevalencia del Virus del papiloma humano (VPH) en muestras endocervicales de mujeres asintomáticas procedentes de la Ciudad de Cajamarca”.

Dicha investigación fue de tipo descriptivo, de corte transversal retrospectivo observacional. Cuya población fueron mujeres con cepillado del Hospital Docente de Cajamarca, y con una muestra de 568 mujeres, donde para determinar si tiene el virus de papiloma humano se utilizó muestras del cérvix uterino bajo la prueba de PCR. En dicha investigación se observó que el 17.8% (101) de las muestras fueron positivas, de las cuales el 51.5% tuvieron entre los 17 a 20 años, las mujeres positivas al VPH tuvieron en su mayoría 3 parejas sexuales con en 62.4%, el 72% del total de positivas no usan el preservativo y el 85% cuenta con historial de ITS. Por lo que esta investigación concluye que los factores más frecuentes para el VPH son: el historial de ITS, el número de aborto de cada mujer y por último el número de partos (18).

Iglesias Osoreo y Serquén López. (2020). En su investigación tuvieron como objetivo “Determinar la prevalencia del virus de papiloma humano y los factores asociados en mujeres con citología desconocida”. Dicha investigación fue de tipo descriptivo de corte transversal, la población que se utilizó fueron las pacientes con citología desconocida del Hospital Regional Lambayeque entre abril a junio del 2019 y por medio de un muestreo no probabilístico se recolectó 177 muestras, donde 53 mujeres fueron positivas a VPH y 124 negativas a VPH. Los resultados de dicha investigación revelan que no existe relación alguna entre los factores de riesgo empleados y la exposición del virus de papiloma humano. Los factores de riesgos más relevantes fueron: Inicio de las relaciones sexuales, número de parejas sexuales, consumo de tabaquismo, antecedentes de ITS, uso de método hormonal, uso del condón (19).

Gonzales R. (2022). En su investigación tuvo como objetivo “Determinar la prevalencia y tipos del virus del papiloma humano (VPH) oncogénico en mujeres de 30 a 65 años, atendidas en el Hospital Nacional Dos de Mayo durante el año 2018.” Dicha

investigación fue de tipo no experimental, transversal y retrospectivo. Donde la población fue de 846 mujeres con diagnóstico de PAP y tipificación de PVH, con una muestra de 103 mujeres según los criterios de inclusión, para obtener la información necesaria se utilizó una ficha de recolección de datos donde los resultados fueron: 47 mujeres con PVH positivo, y 56 mujeres con PVH negativo, donde los genotipos más comunes de VPH fue el genotipo Pool de alto riesgo oncogénico con un 41%, seguido del VPH 16 con un 4.9% y por último en gen 18 con solo un 1% (20).

2.2.Bases teóricas

2.2.1. Virus Del Papiloma Humano

El virus del papiloma humano (VPH) es un virus de ADN de doble hebra que forma parte de la familia *Papillomaviridae*. Cada tipo de VPH posee una cápside distintiva y su tamaño ronda los 52 nanómetros. Su replicación ocurre específicamente en el núcleo de células escamosas y queratinocitos. El VPH se multiplica exactamente en el núcleo de las células de los queratinocitos y escamosas (21). La proteína capsular de los diversos tipos de VPH es muy similar por lo que este virus se divide por la secuencia de ADN. La proteína capsular se divide en dos proteínas estructurales la L1 al 95% y L2 solo en un 5 %, al combinarse ambos tipos de proteínas se forma un capsómero icosaédrico.

Por otro lado, existen dos proteínas fundamentales en el proceso patológico del virus que son la E6 y la E7, las dos proteínas son los portadores del VPH y actúan de manera en conjunta para atacar las células de epitelio (22). Existen más de 150 tipos distintos de VPH y esto se debe a las secuencias del diferenciados ADN, de las 150 cepas diferentes, el 40% se aloja en el aparato genital inferior en su mayoría infectando las células epiteliales del cérvix (23).

La infección por VPH es la infección de transmisión sexual más común, este virus se contagia fácilmente durante las relaciones sexuales, las células basales del virus invaden el epitelio urogenital por medio de pequeñas lesiones de la mucosa misma. Esta infección es muy común entre los adolescentes y jóvenes con una vida sexual activa. El sexo es el principal modo de transmisión (24).

2.2.2. Clasificación del VPH

El papilomavirus humano pertenece a la familia de Papillomaviridae en un grupo de virus que tiene propiedad de infectar desde aves hasta a mamíferos especialmente al humano. Esta familia de Papillomaviridae se dividen en géneros según su secuencia genética o características biológicas tales como las propiedades oncogenas y no oncogenas. El género *Alphapapillomavirus* se divide en 15 especies cada uno con genotipos diferentes pero relacionados todos a causar cáncer en el huésped. Por otro lado, los géneros *Betapapillomavirus* y *Gammapapillomavirus* no tienen propiedades oncogenas y suelen ser asintomáticas, siempre y cuando la persona tenga un estado inmunológico fuerte, porque ante un estado de inmunosupresión puede generarse papilomas cutáneos. (25) (26).

Se dividieron en dos grupos generales los más de 150 tipos de papilomavirus humano, los denominados de bajo riesgo que son los encargados de proliferar verrugas en diferentes partes del cuerpo tales como el área genital, ano, la boca o garganta. Este tipo de virus raramente causa cáncer de cuello uterino, pero ocasionar problemas respiratorios si las verrugas se proliferan en la laringe o vías respiratoria, Los tipos más comunes son los serotipos 6 y 11 (25). Por otra parte, el VPH de alto riesgo es el más peligroso y letal si no se trata a tiempo, ya que este es el causante de las alteraciones intraepiteliales del cuello uterino y por ende, de un posible cáncer de cuello cérvix. Los genotipos de alto riesgo son doce, las cuales los más comunes son el 16 y 18. Entre los

tipos de cáncer que pueden generar son: cáncer cervical en mayor proporción, cáncer anal, vaginal, de vulva y en menos proporción a nivel orofaríngeo (21)

2.2.4. Historia natural de VPH y el cáncer de cuello uterino

El virus de papiloma humano es una infección de transmisión sexual que afecta no solo a las mujeres, sino también en gran porcentaje al hombre, de esta manera ambos géneros se encuentran involucrado en una cadena epidemiológica. Donde cualquiera puede ser el portador sin saberlo ya que este virus puede ser también asintomático y transmitir a otra persona convirtiéndolo en víctima de la infección (27).

La historia natural del VPH comienza con una pequeña infección de la capa basal del epitelio por medio de lesiones de la mucosa, y para que el virus asegure su lugar necesita infectar células con capacidad de proliferación como son los epitelios endocervicales. Por medio de la replicación de viriones el virus se expande desde el epitelio hasta el exterior del cuerpo atacando poco a poco. En la primera etapa las partículas del virus suprimen respuestas inflamatorias por medio de su vida intraepitelial sin entrar a la circulación con el propósito de evadir al sistema inmune del huésped, luego ya en las etapas más avanzadas genera con fuerza inflamaciones crónicas que pueden generar hasta la aparición de cáncer (1).

2.2.5. Diagnóstico del VPH

Prueba molecular de VPH

La prueba molecular de VPH es un examen de laboratorio donde se detecta la presencia de ADN en el cuello uterino, donde se busca detectar principalmente VPH de alto riesgo quien es el causante de las alteraciones celulares. En el Perú, por medio del Ministerio de Salud se comenzó a tamizar a las mujeres mayores de 29 años con el fin de detectar precozmente la infección.

El Odo, es una plataforma del Estado Peruano donde se registran y se entregan resultados de PVH realizados por el MINSA, dicho sistema nos arroja si la mujer quien se sometió al tamizaje presenta VPH de alto riesgo tipo a PVH 16, 18 o Otros de alto riesgo o por el contrario si es negativo a VPH.

Colposcopia

La colposcopia para detectar VPH consiste en examinar el cuello uterino, la vagina y vulva con el fin de detectar anomalías, esta prueba se realiza generalmente cuando se encuentra algo anormal en la citología cervical o ante un tamizaje de VPH puesto que se puede identificar cambios a nivel celular previniendo un cáncer de cuello uterino.

2.2.6. Características sociodemográficas

El termino sociodemográfica se refiere a un conjunto de atributos o de datos que se relaciona a una población o comunidad, se considera datos sociales como demográficos y para la presente investigación se van a utilizar: edad, estado civil, nivel de estudios, ocupación, consumo de tabaco u alcohol.

Nivel educativo

Grado de estudio más alto alcanzado por una persona, el cual puede ser desde primaria completa, secundaria completa o grado superior ya sea universitario o instituto. Diversos estudios señalan que una de las principales características de las mujeres con VPH es la carencia de nivel educativo puesto que una mujer sin educación podría estar expuesta a la falta de conocimiento preventivo ante la infección.

Estado civil

El estado civil es la determinación que se es impuesta a una persona con respecto a la familia de acuerdo con la legislación matrimonial o conyugal.

Consumo de tabaco

Tanto quienes fuman directamente como quienes inhalan el humo de forma pasiva están expuestos a múltiples sustancias cancerígenas, las cuales ingresan al torrente sanguíneo a través de los pulmones y pueden afectar distintos órganos del cuerpo. Estudios recientes indican que las mujeres que fuman mayor probabilidad de desarrollar cáncer de cuello uterino en comparación con las que no fuman, ya que se han encontrado residuos del tabaco en el cérvix, los cuales podrían alterar las células de esta zona y favorecer la aparición del cáncer en el futuro (28).

2.2.6. Características gineco-obstétricas

Número de parejas sexuales

Es el total de personas con la que se mantuvo intimidad, sea o no con un vínculo afectivo, y se caracteriza mucho en mujeres con VPH y más de 2 parejas sexuales.

Inicio de relaciones sexuales tempranamente

Iniciar la vida sexual antes de los 17 años se asocia con un mayor riesgo de desarrollar lesiones intraepiteliales, debido a que suele ir acompañado de conductas de riesgo, como el no uso de protección y la posibilidad de que la pareja tenga VPH u otra infección de transmisión sexual. Además, quienes comienzan su actividad sexual antes de los 18 años tienden a tener mayor frecuencia de relaciones, lo que incrementa su exposición a diferentes tipos de VPH, un factor que puede influir en la aparición de neoplasias intraepiteliales o cáncer de cuello uterino (29).

Uso de método anticonceptivo hormonal

El uso continuo de anticonceptivos orales durante más de cinco años se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer cervicouterino, debido a los cambios hormonales que provoca. Se ha observado que esta exposición prolongada puede duplicar la probabilidad de desarrollar la enfermedad, especialmente cuando existe presencia de los tipos 16 y 18 del VPH, que son los más comunes.

Número de gestaciones

Es la cantidad de veces que una mujer queda embarazada, independiente si se culmina con la gestación o no. Haber tenido varios embarazos puede indicar la ausencia del uso de métodos anticonceptivos, lo que incrementa la vulnerabilidad frente al virus del papiloma humano. Además, el embarazo produce cambios hormonales y una disminución en el sistema inmunológico, lo que favorece el desarrollo de tumores o la aparición de enfermedades.

2.3. Formulación de hipótesis

2.3.1. Hipótesis general

Por la metodología que adoptara el estudio, en ser de enfoque descriptivo, se excluye realizar una hipótesis general, puesto que solo se analizarán datos para obtener características de las mujeres con VPH positivo.

2.3.2. Hipótesis específica

Debido a ser un estudio de enfoque descriptivo, no será necesario la elaboración de una hipótesis específica dado que solo buscaremos analizar datos sin correlacionarlos entre sí y nos centraremos solo en ver las características, junto con la tipificación de mujeres con VPH.

3. METODOLOGÍA

3.1. Método

Según Matas T, Un método de investigación es una vía que se sigue para alcanzar un objetivo, en este caso, la obtención de conocimiento científico, y que con el tiempo ha sido clasificado en distintas categorías: Método deductivo, hipotético-deductivo y inductivo. (30). Esta investigación usará el método deductivo, puesto que se aplicará teorías generales para deducir y llegar a una conclusión.

3.2. Enfoque

Según Acosta S, el enfoque de investigación se refiere a la perspectiva tanto teórica o metodológica que se adopta para realizar un estudio de un problema. Representa también los planteamientos, la visión, la orientación y la manera en que el investigador interpreta la realidad, la cual determina cómo se aproxima al fenómeno que desea analizar (31). El enfoque metodológico puede ser cualitativa, cuantitativa o mixta. Para este presente estudio se realizará una investigación cuantitativa ya que buscaremos recolectar datos, se medirán y analizarán las variables.

3.3. Tipo de investigación

Vizcaíno P. et al, mencionan que la investigación representa un proceso estructurado que permite alcanzar un propósito específico, pudiéndose así dividir en básica y aplicada, la investigación básica se centra en ampliar conocimiento de un tema determinado por lo contrario la investigación aplicada se basa en ampliar conocimiento y aplicarlo para resolver problema o mejorar situaciones (32). Para este trabajo se aplicará una investigación básica, puesto que solo buscaremos conocimientos teóricos.

3.4.Diseño de investigación

Según Tarrillo S, et al. el diseño de investigación se puede dividir en no experimental y experimental, donde cada uno son diferente entre sí y se caracteriza en las distintas formas de manejar las variables, igualmente se refiere al plan que se hará para la recolección de datos que desees (33). Para este estudio se clasifico como no experimental, descriptivo, transversal y retrospectivo.

Se considera un estudio no experimental o llamado también observacional, ya que no se manipularán las variables, sino que solo se observara y describirán las variables. El diseño se considerará como retrospectivo debido a que se recolectará los datos de historias clínicas con mujeres con VPH positivo ya registradas.

Corte: será de corte transversal puesto que solo buscaremos recopilar datos de un tiempo determinado, en este caso se recolectares las historias clínicas de mujeres con VPH positivo de enero del 2024 a agosto del 2025.

Nivel o alcance: Sera descriptivo ya que solo nos centraremos en describir las variables elaboradas para describir las características y el tipo de cepa más común que atacan a las mujeres del Centro de Salud Mirones Bajo.

3.5.Población, muestra y muestreo

3.5.1. Población

Según Vizcaíno P et al, la población es el total de sujetos, eventos u objetos a estudiar con las mismas características, y que se describe casi siempre impracticable o con un costo elevado para investigarlo en su totalidad (32). La población de la presente investigación está constituida por 60 historias clínicas de mujeres con resultado de prueba molecular de VPH positivo. Con el fin de que la población seleccionada sea adecuada para los objetivos de esta investigación se realizara criterios de selección:

Criterio de inclusión:

- Historia clínica con diagnóstico de VPH positivo entre enero del 2024 a agosto del 2025.
- Historias clínicas completas
- Mujeres entre los 30 a 49 años de edad.

Criterios de exclusión

- Historias clínicas incompletas.
- Historias clínicas con datos ambiguos.

3.5.2. Muestra

Según Arias y Covinos la muestra es un subconjunto de la población que comparten las características necesarias para poder representar todo el estudio, igualmente mencionan que no hay una cantidad específica de muestra, pero si se debe de considerar delimitar correctamente según el propósito de la investigación (34). Para la presente investigación, se utilizará el total de la población debido a que será un muestreo censal por lo que no será necesario la implementación de fórmula para determinar el tamaño de muestra. La muestra del estudio serán las 60 historias clínicas de mujeres con prueba molecular de VPH positivo.

3.5.3. Muestreo

Según Vizcaíno P. et al, el muestreo se basa en recolectar a un grupo de interés, es decir agrupar a participantes con experiencias o características particulares que sean importante para el estudio, el muestreo puede ser probabilístico donde se recolecta a los participantes a lazar o no probabilístico donde se escoge solo a cierto grupo de específico ya sea por complejidad o por falta de interés para el estudio (35). Para efecto

de la investigación, será un muestreo censal retrospectivo y se justifica al que ser un grupo pequeño de 60 historias clínicas es más accesible evaluar a toda la población en su totalidad por lo que no fue necesario la implementación de fórmula para el tamaño muestra.

3.6. Variables y operacionalización

Variables y operacionalización

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Escala valorativa (niveles o rangos)
Variable 1: Características de las mujeres con VPH	Son ciertos patrones o similitudes que tiene las mujeres con diagnóstico de VPH	Son las características tanto sociodemográfica y gineco-obstétrica que presentan las mujeres del	Características Sociodemográficas	Edad	Ordinal	30- 40 años / 41 a 45 años /46 a 49 años
				Estado civil	Nominal	Soltera/casada/Conviviente/viuda
				Grado de instrucción	Nominal	Primaria/Secundaria/Superior o técnico/ No estudio
				Consumo de tabaco	Nominal	Si / No
				Menarquia	Ordinal	De 11 a menos años/ 12 a 14 años / 15 años a más.
				Inicio de relaciones sexuales	Ordinal	De 20 años a mas/ 18 a 19/ 16 a 17/ menos de 16 años

		Centro de Salud Mirones Bajo.		Parejas sexuales	Ordinal	Menos de 3/ más o igual a 3
				Antecedente de ITS	Nominal	Si / No
				Número de hijos	Ordinal	0/ 1 a 2/ 3 a 4/ 5 a más
				Anticonceptivos hormonales	Nominal	Solo progestágeno/ Combinado/ No uso MAC hormonal
				Uso del condón	Nominal	Si/ no
				PAP anterior (ultimo 2 años)	Nominal	Negativo/ Positivo/ no hay
Variable 2: Tipificación de PVH	La tipificación del VPH es un análisis médico que	Es el tipo de cepa que se encontrara en las mujeres tamizadas de CSMB	VPH 16 VPH 18	Tipo de cepa 16 Tipo de cepa18	Nominal Nominal	Si/no Si/no

identifica el	Otros de alto	Tipo de cepa Otros	Nominal	Si/no
tipo	riesgo	De alto riesgo		
específico				
de VPH)				

3.7.Procedimiento y técnica

3.7.1. Técnica

La técnica es un procedimiento u herramientas que se utiliza en la investigación para recolectar y analizar datos de manera más precisa. Para la presente investigación se utilizará la técnica de análisis documental, por lo que se revisará historias clínicas y se llena una ficha de datos (32).

3.7.2. Instrumento

Como instrumento para la presente investigación se utilizará una ficha de recolección de datos elaborada por Robles P, en el año 2023 el cual consiste de 8 ítems, dicho instrumento consta de tres partes, la primera sobre los resultados de la prueba molecular de VPH, la segunda sobre las características sociodemográficas con tres ítems, la tercera parte sobre las características ginecobstetricias con 4 ítems más (35).

Este instrumento para la presente investigación será modificado y se agregará ciertos ítems puesto a que se consideró que así se ajustará más al propósito del trabajo, igualmente la ficha general será evaluada por expertos en este campo para su validación, tomando en cuenta sugerencias para mejorar el trabajo de investigación.

El instrumento constara de las siguientes partes:

- I. Características sociodemográfico: Edad, estado civil, nivel de educación, consumo de tabaco.
- II. Características gineco-obstétrico: Inicio de relaciones sexuales, número de parejas sexuales, menarquia, gestaciones, usos anticonceptivos hormonales y toma del PAP (Ultimo 3 años), uso de condón, antecedente de ITS.
- I. Tipificación de VPH: VPH 16, VPH 18, VPH otros de alto riesgo.

3.7.3. Validación

Según Monje A, la validación es la garantía de que tan bien está estructurado el instrumento a utilizar, proporcionando resultados relevantes, lo cual se necesita recurrir a personas con gran conocimiento en estos temas para que evalúen el instrumento (36).

Robles P. (37) validó su instrumento de autoría propia en el año 2023, el cual fue evaluado por tres médicos especialistas en ginecología y obstetricia. Los 3 evaluadores constataron para su validación claridad, coherencia, suficiencia y relevancia y fue aprobada por unanimidad.

El instrumento de Robles será modificado y adaptado por mi persona según las características de mi población objetivo y será sometida a la verificación de tres expertos en la materia, quienes evaluarán la pertinencia, relevancia y claridad, tomando en consideración las sugerencias del caso. (Anexo 2 y 3)

3.7.4. Confiabilidad

Igualmente, Monje A, menciona que la confiabilidad es la capacidad que tiene el instrumento en sí para dar datos reales aplicándolo reiteradamente al mismo sujeto de estudio. En este sentido para nuestra investigación no aplica la confiabilidad para el instrumento (36).

3.8. Análisis de Datos

Todos los datos obtenidos serán plasmados en una hoja Excel, donde se examinará con cuidado para asegurar la calidad de información para la investigación. Los parámetros para ello serán, verificar que no exista duplicación de resultados o casillero vacíos o con errores.

Para el análisis descriptivo de las variables, se utilizará el programa de SPSS v26 para el análisis descriptivo de las variables se hará el cálculo de frecuencia absolutas y relativas, lo cual se hará en tres partes, primero para las características sociodemográficas, luego las caracterizas gineco obstétricas y por último la tipificación de VPH. Por último, los datos obtenidos serán mostrados mediante gráficos circulares por medio del programa Microsoft Excel 2024.

3.9.Aspectos éticos y de integridad científica

Para la ejecución de esta investigación se procederá a realizar la solicitud de permiso el cual será evaluada por el Comité de Ética de la Universidad Norbert Wiener según sus lineamientos y ya con la confirmación. Se remitirá una carta de presentación a la DIRIS LIMA CENTRO para que evalúe mi investigación y autorice el permiso para la aplicación de mi trabajo de investigación en el Centro de Salud Mirones Bajo, ya debido al tipo de investigación, este no cuenta con un consentimiento informado por lo que se espera la autorización de las autoridades del Centro de Salud.

La recolección de datos se realizará con estrictas medidas de confidencialidad. Se protegerán los datos de cada paciente, no divulgando la información a terceros, así se evitará la identificación de pacientes. Igualmente, la única que tendrá acceso a las historias clínica será mi persona y los datos obtenidos serán plasmados solo en dispositivos electrónicos con clave para mayor seguridad.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. CRONOGRAMA

N	Actividad	(2025)					
		Jul	Agost	Sept	Oct	Nov	Dic
1	Planteamiento del problema, fundamentación teórica y justificación	x					
2	Formulación de los objetivos de investigación	x					
3	Metodología de la investigación	X					
4	Población de estudio		X				
5	Elaboración y validación de los instrumentos de recolección de datos.		x				
6	Desarrollo de los aspectos administrativos y redacción del proyecto de investigación			X			
7	Revisión del proyecto de investigación por el Comité de Ética para la Investigación.			X			
8	Levantamiento de Observaciones.			X			
9	Aprobación del proyecto			X			
10	Autorización del establecimiento de estudio				X		
11	Reclutamiento de la información				x	X	
12	Procesamiento de la información						X
13	Informe final						x
14	Sustentación						x

4.2. PRESUPUESTO

	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
RECURSOS HUMANOS			
Estadístico	S/350	1	S/350
Digitadora	S/150	1	S/150
RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS			
Laptop	S/1000	1	S/ 1000
Fólderes	S/ 5	2	S/ 10
Caja de Lapiceros	S/ 40	1	S/ 40
Papel bond 80 gr paquete.	S/14.0	1	S/14
SERVICIOS			
Internet (mes)	S/ 30	6	S/ 180
Luz eléctrica (mes)	S/ 50	6	S/ 300
Fotocopias	S/ 0.05	100	S/ 35
Impresión	S/0.20	50	S/10
GASTOS IMPREVISTOS			
Refrigerios	S/10.00	10	S/ 100
Movilidad	S/ 5.00	20	S/ 100
TOTAL			S/2289

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Toro Montoya AI, Tapia Vela L. Virus del papiloma humano (VPH) y cáncer. Medicina & Laboratorio. 2021; 25(2).
2. Núñez Troconis J. Epidemiología del virus del papiloma humano. Invest. clín. 2023; 63(2).
3. Organización Panamericana de la Salud. Vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). [Online]; 2022. Acceso 23 de Juniode 2025. Disponible en: <https://www.paho.org/es/vacuna-contravirus-papiloma-humano-vph#:~:text=La%20mayor%20prevalencia%20de%20infecciones,variable%20seg%C3%BA%20las%20tendencias%20sexuales>.
4. World Health Organization. One in three men worldwide are infected with genital human papillomavirus.[Internet]. Ginebra. [Online]; 2023. Acceso 23 de Juniode 2025. Disponible en: <https://www.who.int/news/item/01-09-2023-one-in-three-men-worldwide-are-infected-with-genital-human-papillomavirus>.
5. International Agency for Research on Cancer. Global Cancer Observatory: Cancer Today. GLOBOCAN. [Online]; 2022. Acceso 24 de Juniode 2025. Disponible en: https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-multi-bars?v=2020&mode=cancer&mode_population=countries&population=900&populations=900&key=asr&sex=0&cancer=39&type=0&statistic=5&prevalence=0&population_group=0&ages_group%5B%5D=0&ages_group%5B%5D=17&nb_items=10&.
6. Ministério da Saúde. Taxa de HPV na genital atinge 54,4% das mulheres e 41,6% dos homens no Brasil, diz estudo.[Internet]. Brasília. [Online].; 2023. Acceso 20 de Junio de 2025. Disponible en: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/dezembro/taxa-de-hpv-na-genital-atinge-54-4-das-mulheres-e-41-6-dos-homens-no-brasil-diz-estudo>.
7. Ministerio de Salud y Deportes. Gobierno avanza en la detección temprana del cáncer de cuello uterino con 44.320 pruebas del vph, que este año ampliará a todos los departamentos.[Internet]. [Online].; 2025. Acceso 12 de Junio de 2025. Disponible en: <https://www.minsalud.gob.bo/8520-gobierno-avanza-en-la-deteccion-temprana-del-cancer-de-cuello-uterino-con-44-320-pruebas-del-vph-que-este-ano-ampliara-a-todos-los-departamentos>.
8. Araujo J, Ramon Cotrina M, Quispe Martinez R, Rios Rios M, Quispe Gonzaga M, Saldaña Reyes C, et al. Prevalence of HPV in a Peruvian Healthcare Network: A Descriptive Cross-Sectional Study. SageJournals. 2025; 32.
9. Ministerio de Salud. El virus de papiloma humano (VPH) está relacionado con el 99 % de los casos de cáncer de cuello uterino.[Internet]. Lima. [Online]; 2023. Acceso 23 de Juniode 2025. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/734327-el-virus-de-papiloma->

[humano-vph-esta-relacionado-con-el-99-de-los-casos-de-cancer-de-cuello-uterino.](#)

10. Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). SALA SITUACIONAL DE CÁNCER EN EL PERÚ,[Internet]. [Online].; 2024. Acceso 24 de Junio de 2025. Disponible en:
[https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/sala/2024/SE32/cancer.pdf.](https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/sala/2024/SE32/cancer.pdf)
11. Ministerio de Salud. Más de 141 000 mujeres se han realizado una prueba de VPH para el tamizaje de cáncer de cuello uterino en el presente año.[Internet].Lima. [Online]; 2025. Acceso 25 de Juniode 2025. Disponible en:
[https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/1171751-mas-de-141-000-mujeres-se-han-realizado-una-prueba-de-vph-para-el-tamizaje-de-cancer-de-cuello-uterino-en-el-presente-ano.](https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/1171751-mas-de-141-000-mujeres-se-han-realizado-una-prueba-de-vph-para-el-tamizaje-de-cancer-de-cuello-uterino-en-el-presente-ano)
12. Dirección Regional de Salud Huancavelica. Realizan campaña de detección molecular del Virus del Papiloma Humano VPH.[Intener]. [Online]; 2024. Acceso 25 de Juniode 2025. Disponible en:
[https://www.gob.pe/institucion/regionhuancavelica-diresa/noticias/900646-realizan-campana-de-deteccion-molecular-del-virus-del-papiloma-humano-vph.](https://www.gob.pe/institucion/regionhuancavelica-diresa/noticias/900646-realizan-campana-de-deteccion-molecular-del-virus-del-papiloma-humano-vph)
13. Laica Sailema N, Hernández Bandera N, Lana Cisneros J, Lara Jacome A. Prevalencia de VPH y factores de riesgos en mujeres universitarias sintomáticas y asintomáticas, Ecuador 2020. Boletín de Malariología y Salud AMniental. 2021; 61(2): p. 240-247.
14. Morales Figueroa GG, Bravo Parra M, Olivas Matas , Esparza Romero J, Valenzuela Zamorano M, Olivas López O, et al. Factores asociados a la infección por el virus del papiloma humano en mujeres del noroeste de México. Biotecnia. 2023; 25(1): p. 133-139.
15. Jordá GB, Ramos JM, Mosmann J, Lopez ML, Wegert A, Cuffini C. Prevalencia del virus papiloma humano y factores de riesgo asociados en mujeres afiliadas al seguro de salud estatal en Posadas, Misiones (Argentina). Rev. chil. infectol. 2020; 37(2).
16. Di Yang , Jing Zhang , Xiaoli Culi , Jian Ma , Chunyan Wang , Haozhe Piao. Risk Factors Associated With Human Papillomavirus Infection, Cervical Cancer, and Precancerous Lesions in Large-Scale Population Screening. Front. Microbiol. 2022; 13(914516).
17. Rodríguez Bercera E. Características y tipos del virus del papiloma humano de alto riesgo en mujeres de 30 a 65 años en el Centro Médico y Oncológico Juan XXIII 2022.[Tesis para optar el grado de segunda especialidad en atención primaria en prevención del cáncer ginecológico] Lima; 2024.
18. Denegri Hinostroza D. Prevalencia del Virus del Papiloma Humano (VPH) en muestras endocervicales de mujeres asintomáticas de la Ciudad de Cajamarca, [tesis para optar el título profesional en Biología] Lima; 2024.

19. Iglesias Osore S, Serguén López L. Virus papiloma humano y factores asociados en pacientes con citología desconocida atendidas en el norte de Perú. *Rev. peru. ginecol. obstet.* 2020; 66(3).
20. Ayala Quintanilla B. Prevalencia y tipos de virus papiloma humano oncogénicos en mujeres de 30 a 65 años Hospital Nacional Dos de Mayo, 2018.[tesis para optar título de médico cirujano] Lima; 2022.
21. Iglesias Osore S. Prevalencia de virus papiloma humano en pacientes de Gineco-obstetricia del Hospital Regional Lambayeque, abril –mayo 2019.[Tesis para optar el título profesional de Biología] Lambayeque; 2020.
22. Rengifo Rodriguez J, Osorio J, García Perdomo H. Virus del papiloma humano (VPH): microbiología, relación con el cáncer de pene y características de la vacuna. *Rev. mex. urol.* 2022; 80(4).
23. Hernández Guzmán T, González Calderón V, Ozal Mora N, González Blanco M. Infección genital por el virus de papiloma humano: Grado de información que poseen las pacientes. *Rev Obstet Ginecol Venez..*
24. Ponce Blas SdC, Rojas Cisneros. Factores de riesgo asociados a neoplasia intraepitelial cervical de alto grado en mujeres atendidas en el servicio de Ginecología Oncológica del Hospital María Auxiliadora, periodo 2016-2021[tesis para optar el grado academico de Medico Cirujano] Lima; 2022.
25. Murillo Zavala , Morales Pinargote M, Quimiz Limo M. Virus del papiloma humano: una actualización al diagnóstico y la prevención. *Dom. Cien.* 2022; 8(2).
26. Sendagona Cudos E, Burgos Cibrian J, Rodríguez Iglesias M. Infecciones genitales por el virus del papiloma humano. *Enferm Infecc Microbiol Clin.* 2019; 37(5).
27. Prado Peláez J, Hernández Pacheco , Ruvalcaba Ledezma J, Ceruelos Hernández MdC. VPH: generalidades, prevención y vacunación. *JONNPR.* 2023; 6(2).
28. Rojas Cisneros N, Ruíz Saucedo R. CONSUMO DE TABACO Y NEOPLASIA INTRAEPITELIAL. *Rev. Fac. Med. Hum.* 2021; 21(1).
29. Gonie Mekonnen , Moges Mittiku. Early-onset of sexual activity as a potential risk of cervical cancer in Africa: A review of literature. *PLOS Global Public Health.* 2023; 3(3).
30. Matas Terrón A. El Método Científico: una breve introducción. En Matas Terrón A. *Introducción a la Investigación en Ciencias de la Educación: Bubok.*; 2023.
31. Acosta Faneite S. Los enfoques de investigación en las Ciencias Sociales. *REVISTA LATINOAMERICANA OGMIOS.* 2023; 3(8): p. 82-95.
32. Vizcaíno Zúñiga P, Cedeño Cedeño R, Maldonado Palacios I. Metodología de la investigación científica: guía práctica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar.* 2023; 7(4).

33. Tarrillo Saldaña O, Mejía Huamán J, Dávila Mego J, Pintado Castillo C. Metodología de la investigación una mirada global Ejemplos prácticos. 1st ed.: CID - Centro de Investigación y Desarrollo; 2024.
34. Arias Gonzáles JL, Covinos Gallardo M. Diseño y metodología de la investigación 2021. 1st ed.: Enfoques Consulting Eirl; 2021.
35. Vizcaíno Zúñiga PI, Cedeño Cedeño RJ, Maldonado Palacios IA. Metodología de la investigación científica: guía práctica. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar. 2023; 7(4).
36. Monje Álvarez C. Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa Guía didáctica: Universidad Surcolombiana ; 2011.
37. Robles Palacios F. PREVALENCIA DEL VIRUS DE PAPILOMA HUMANO EN MUJERES SEXUALMENTE ACTIVAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CHANCAS DE ANDAHUAYLAS – SANTA ANITA – PERÚ, 2022. [Tesis para optar el Título Profesional de Médico Cirujano] Lima; 2023.

Anexo 1: Matriz de Consistencia

Formulación del problema	Objetivos	Hipótesis	Variables	Diseño metodológico
Problema genera:	Objetivo general	Hipótesis general.	Variable 1	Tipo de investigación:
¿Cuál es la tipificación del virus de papiloma humano y características de las mujeres del Centro de Salud Mirones Bajo, 2024-2025?	Determinar la tipificación del virus de papiloma humano y características de las mujeres del Centro de Salud Mirones Bajo, 2024-2025	Para el estudio, no es necesario	-Características de mujeres con VPH Dimensiones: -Características Sociodemográficas - Características Gineco-obstétricas	Básica Método y diseño de la investigación: Cuantitativa, descriptiva, transversal
Problemas específicos	Objetivos específicos	Hipótesis específica:	Variable 2:	Población: 60 historias clínicas de mujeres con
¿Cuáles son las características sociodemográficas	Conocer las características sociodemográficas	Para el estudio,	- Tipificación de PVH	

de mujeres con infección al virus de papiloma humano?	de mujeres con infección al virus de papiloma humano.	no es necesario	Dimensiones -VPH16 -VPH 18 VPH otro de alto riesgo.	resultado de prueba molecular de VPH positivo.
• ¿Cuáles son las características gineco-obstétricas de mujeres con infección al virus de papiloma humano?	• Establecer las características gineco-obstétricas de mujeres con infección al virus de papiloma humano.			Muestra: Serán las 60 historias clínicas de mujeres con resultado de prueba molecular de VPH positivo por ser una muestra censal
• ¿Qué tipo de cepa prevalece en las mujeres con infección de virus de papiloma humano?	• Identificar que cepa prevalece en las mujeres con infección de virus de papiloma humano.			

Anexo 2: Instrumento

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

INSTRUMENTO ELABORADO POR ROBLES P, AÑOS 2023

MODIFICADO POR MI PERSONA MENDOZA A, 2025

Numero de Historia clínica:

VARIABLE I: CARACTERISTICAS

DIMENSION 1: Características sociodemográficas

1. Edad: _____ años

2. Estado civil

☐ Soltera ☐ Casada ☐ conviviente ☐ divorciada

3. Grado de instrucción

☐ Técnico o superior ☐ Secundaria ☐ Primaria ☐ No estudios

4. Consumo de tabaco

☐ Si ☐ No

DIMENSION 2: Características gineco-obstétrica

5. Menarquia

☐ igual o menor de 12 años ☐ 13- 14 años ☐ 15 a más años

6. Parejas sexuales

☐ Menos de 3 ☐ Más o igual de 3

7. Inicio de edad de las RS

☐ De 20 años a más ☐ 18 a 19 años ☐ 16 a 17 años ☐ Menos de 16 años

8. Número de hijos

☐ 0 ☐ 1 a 2 ☐ 3 a 4 ☐ 5 a más

9. Resultado de PAP ultimo (ENTRE LOS 3 AÑOS)

☐ Normal ☐ Anormal ☐ No tiene

10. Antecedente de ITS

☐ SI ☐ No

11. Método anticonceptivo hormonal

☐ Solo progestágeno ☐ Combinado ☐ No uso MAC hormonal

12. Uso del condón

☐ Si ☐ No ☐ a veces

VARIABLE II: TIPIFICACIÓN DE VPH

DIMENSION 1: VPH 16

13. Con VPH 16

☐ SI ☐ No

DIMENSION 2: VPH18

14. Con VPH 18

() SI () No

DIMENSION 3: VPH OTROS DE ALTO RIESGO

Con VPH otros de alto riesgo: () SI () No

ANEXO 3: VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

1. PRIMER EXPERTO: Walter Enrique Tapia Núñez

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN

Tipificación del virus de papiloma humano y características de las mujeres en el Centro de Salud Mirones Bajo. 2024-2025

Instrumento elaborado por Robles P, en el año 2023. Modificado por Ariana Mendoza en el año 2025

N °	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹	Relevancia ²	Claridad ³	Sugerencias
Variable 1: Características de las mujeres con VPH					
	DIMENSIÓN 1: Características sociodemográficas	SI No	SI No	SI No	
1	Edad	SI No	SI No	SI No	
2	Estado civil	SI No	SI No	SI No	
3	Nivel Educativo	SI No	SI No	SI No	
4	Consumo de tabaco	SI No	SI No	SI No	
	DIMENSIÓN 2: Características gineco-obstétrica	SI No	SI No	SI No	
5	Menarquia	SI No	SI No	SI No	
6	Inicio de relaciones sexuales	SI No	SI No	SI No	
7	Parejas sexuales	SI No	SI No	SI No	
8	Números de hijos	SI No	SI No	SI No	
9	Resultado de PAP ultimo (últimos 3 años)	SI No	SI No	SI No	
10	Antecedente de ITS	SI No	SI No	SI No	
11	Métodos anticonceptivos hormonales	SI No	SI No	SI No	
12	Uso del condón	SI No	SI NO	SI NO	
Variable 2: Tipificación del VPH					
	DIMENSIÓN 3: VPH 16	SI No	SI No	SI No	
13	Con cepa VPH 16	SI No	SI No	SI No	
	DIMENSIÓN 4: VPH 18	SI No	SI No	SI No	
14	Con cepa VPH 18	SI No	SI No	SI No	
	DIMENSIÓN 5: VPH OTROS DE ALTO RIESGO	SI No	SI No	SI No	
15	Con VPH Otros de alto riesgo	SI No	SI No	SI No	

¹ **pertinencia:** el ítem corresponde al concepto teórico formulado.

² **relevancia:** el ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.

³ **claridad:** se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Nota. Suficiencia: se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

Observaciones (precisar si hay suficiencia):

Si hay suficiencia.

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable.

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable ☒

Aplicable después de corregir ☐

No aplicable ☐

Apellidos y nombres del juez validador: Dr./Mg.

Tapia Nolasco, Walter Enrique

DNI: *07318544*

Especialidad: Metodólogo ☐

Temático ☐

Estadístico ☐

Especialidad del validador: *Docencia - Obstetra.*

26

..... de Agosto de 2025.

Walter Enrique Tapia Nolasco
CNP 13396.

Firma del experto Informante

2. SEGUNDO EXPERTO: Mercedes Doris Benavente Ramírez

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN

Tipificación del virus de papiloma humano y características de las mujeres en el Centro de Salud Mirones Bajo. 2024-2025

Instrumento elaborado por Robles P, en el año 2023. Modificado por Ariana Mendoza en el año 2025

N °	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹	Relevancia ²	Claridad ³	Sugerencias
Variable 1: Características de las mujeres con VPH					
	DIMENSIÓN 1: Características sociodemográficas	Si No	Si No	Si No	
1	Edad	Si No	Si No	Si No	
2	Estado civil	Si No	Si No	Si No	
3	Nivel Educativo		SI No	SI No	
4	Consumo de tabaco	Si No	Si No	Si No	
	DIMENSIÓN 2: Características gineco-obstétrica	Si No	Si No	Si No	
5	Menarquia	Si No	Si No	Si No	
6	Inicio de relaciones sexuales	Si No	Si No	Si No	
7	Parejas sexuales	Si No	Si No	Si No	
8	Números de hijos	Si No	Si No	Si No	
9	Resultado de PAP ultimo (últimos 3 años)	Si No	Si No	Si No	
10	Antecedente de ITS	Si No	Si No	Si No	
11	Métodos anticonceptivos hormonales	Si No	Si No	Si No	
12	Uso del condón	Si No	Si NO	Si NO	
Variable 2: Tipificación del VPH					
	DIMENSIÓN 3: VPH 16	Si No	Si No	Si No	
13	Con cepa VPH 16	Si No	Si No	Si No	
	DIMENSIÓN 4: VPH 18	Si No	Si No	Si No	
14	Con cepa VPH 18	Si No	Si No	Si No	
	DIMENSIÓN 5: VPH OTROS DE ALTO RIESGO	Si No	Si No	Si No	
15	Con VPH Otros de alto riesgo	Si No	Si No	Si No	

¹ **pertinencia:** el ítem corresponde al concepto teórico formulado.

² **relevancia:** el ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.

³ **claridad:** se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Nota. Suficiencia: se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

Observaciones (precisar si hay suficiencia):

.....

Opinión de aplicabilidad:

.....

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [x]

Aplicable después de corregir []

No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador: Dr./Mg MERCEDES DORIS BENAVENTE RAMIREZ

DNI: 08669256

Especialidad: Metodólogo []

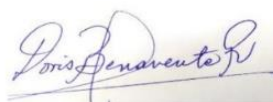
Temático [x]

Estadístico []

Especialidad del validador:

- MAESTRIA EN SALUD PUBLICA CON MENCIÓN EN EPIDEMIOLOGIA
- ESPECIALIDAD EN RIESGO OBSTÉTRICO

19 de agosto de 2025.



Firma del experto informante

3. TERCER EXPERTO: Karina Yovera Palacios de Pillaca

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN

Tipificación del virus de papiloma humano y características de las mujeres en el Centro de Salud Mirones Bajo. 2024-2025

Instrumento elaborado por Robles P, en el año 2023. Modificado por Ariana Mendoza en el año 2025

N °	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³	Sugerencias
Variable 1: Características de las mujeres con VPH							
	DIMENSIÓN 1: Características sociodemográficas	X	No	X	No	X	No
1	Edad	X	No	X	No	X	No
2	Estado civil	X	No	X	No	X	No
3	Nivel Educativo	X	No	X	No	X	No
4	Consumo de tabaco	X	No	X	No	X	No
	DIMENSIÓN 2: Características gineco-obstétrica	X	No	X	No	X	No
5	Menarquia	X	No	X	No	X	No
6	Inicio de relaciones sexuales	X	No	X	No	X	No
7	Parejas sexuales	X	No	X	No	X	No
8	Números de hijos	X	No	X	No	X	No
9	Resultado de PAP ultimo (últimos 3 años)	X	No	X	No	X	No
10	Antecedente de ITS	X	No	X	No	X	No
11	Métodos anticonceptivos hormonales	X	No	X	No	X	No
12	Uso del condón	X	No	X	No	X	No
Variable 2: Tipificación del VPH							
	DIMENSIÓN 3: VPH 16	Si	No	Si	No	Si	No
13	Con cepa VPH 16	X	No	X	No	X	No
	DIMENSIÓN 4: VPH 18	Si	No	Si	No	Si	No
14	Con cepa VPH 18	X	No	X	No	X	No
	DIMENSIÓN 5: VPH OTROS DE ALTO RIESGO	Si	No	Si	No	Si	No
15	Con VPH Otros de alto riesgo	X	No	X	No	X	No

I.

1 pertinencia: el ítem corresponde al concepto teórico formulado.

2 relevancia: el ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.

3 claridad: se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Nota. Suficiencia: se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

Observaciones (precisar si hay suficiencia):

.....

Opinión de aplicabilidad:

.....

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable ☒

Aplicable después de corregir ☐

No aplicable ☐

Apellidos y nombres del juez validador: Dr./Mg: Karina Yovera Palacios de Pillaca

DNI: 40524611

Especialidad: Metodólogo ☐

Temático ☒

Estadístico ☐

Especialidad del validador:

26 de Agosto de 2025.


firma del experto informante

ANEXO 4: INFORME DEL ASESOR DE TURNITIN

Reporte de similitud

NOMBRE DEL TRABAJO

**Mendoza, Ariana_Tipificación del virus d
e papiloma humano y características en
mujeres del Centro d[1].docx**

AUTOR

Ariana Mendoza

RECuento DE PALABRAS

7448 Words

RECuento DE CARACTERES

40599 Characters

RECuento DE PÁGINAS

33 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

90.4KB

FECHA DE ENTREGA

Sep 12, 2025 10:58 PM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Sep 12, 2025 11:00 PM GMT-5

II.

● 10% de similitud general

Principales fuentes encontradas en las siguientes bases de datos:

- 6% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 8% Base de datos de trabajos entregados
- 1% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

FUENTES PRINCIPALES

Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se mostrarán.

1	Universidad Wiener on 2023-07-01 Submitted works	2%
2	Khulna University of Engineering & Technology on 2025-07-19 Submitted works	2%
3	repositorio.uwiener.edu.pe Internet	1%
4	researchgate.net Internet	<1%

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Lima, 20 de septiembre del 2025.

Autor Responsable:
Ariana Solange Mendoza Sulca

Exp. N°: 2158-2025

Es grato expresarle mi cordial saludo y a la vez informarle que el Comité Institucional de Ética e Integridad Científica de la Universidad Privada Norbert Wiener (CIEIC-UPNW) evaluó y **APROBÓ** el siguiente proyecto de investigación:

Proyecto Titulado: "Tipificación del virus de papiloma humano y características en mujeres del Centro de Salud Mirones Bajo. 2024-2025" Versión Nro. 2, con fecha 13/09/2025.

El cual tiene como Autor(es) a:
Ariana Solange Mendoza Sulca

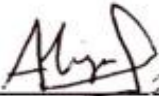
La **APROBACIÓN** comprende el cumplimiento de las buenas prácticas éticas, el balance riesgo/beneficio, la calificación del equipo de investigación y la confidencialidad de los datos, entre otros.

El investigador deberá considerar los siguientes puntos detallados a continuación:

- La **vigencia** de la aprobación es **24 meses** a partir de la emisión de este documento.
- Toda **enmienda** deberá presentarse al CIEIC-UPNW; el proyecto no podrá ejecutarse sin su aprobación previa.
- La constancia de aprobación por el CIEIC **no garantiza la aceptación** por parte de las **instituciones** donde pretende ejecutar el trabajo de investigación.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



Mg. Angelica Karina Minaya Galarreta
Presidente
Comité Institucional de Ética e Integridad Científica
Universidad Privada Norbert Wiener

Lima, Martes 14 de Octubre de 2025

CARTA N° 0387-2025-SG-UPNW-CP

Dr. Pedro Alejandro Cruzado Puente
Director General de la DIRIS Lima Centro
DIRIS Lima Centro
Av. Nicolás de Piérola 589 (Edificio Crillon), Cercado de Lima, Lima

ASUNTO: Autorización para aplicación de estudio de campo

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez presentar a la bachiller de la carrera profesional de **OBSTETRICIA; ARIANA SOLANGE MENDOZA SULCA** con código de matrícula **N° 2019100782** con la finalidad de solicitar se brinde todas las facilidades pertinentes para que pueda aplicar los instrumentos de recolección de datos en **60 historias clínicas de mujeres con prueba molecular de VPH positivo..**

Toda la información que solicita la tesista **ARIANA SOLANGE MENDOZA SULCA** para la elaboración de su proyecto de investigación denominado: **"Tipificación del virus de papiloma humano y características en mujeres del Centro de Salud Mirones Bajo. 2024-2025"** dirigido por la asesoría de tesis de **Mg. HIDALGO VARA LUZ SUSANA**, para la obtención del título profesional en **LICENCIADA EN OBSTETRICIA**.

Agradeciendo por anticipado su autorización a la tesista para que logre su propósito, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Khristian Vigil Vega
DNI: 44025157
RUC: 20486246370
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/10/2025 Hora: 09:13:56